

문제번호	1	교수님	배재훈 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	호흡생리학		
답	④		
해설	surfactant는 표면장력을 감소, compliance를 증가시키죠. 쉬운 문제지만 '용압률=유순도=compliance'가 헛갈려서 나름 오답률이 높은 문제였습니다.		

문제번호	2	교수님	배재훈 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	호흡생리학		
답	④		
해설	1. 기관지 평활근 수축 : acetylcholine(muscarinic), histamine, LT, TXA2, serotonin, PCO2감소 2. 기관지 평활근 이완 : 교감(Epi), <u>β_2 agonist</u> , NO, 작은기도에서 PO2감소 및 PCO2증가		

문제번호	3	교수님	배재훈 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	호흡생리학		
답	①		
해설	① 색전있는 부분은 혈류가 안 흐르니까 폐포 내에서 가스교환을 못하는 생리학적 사강이 증가하겠네요 ② 유순도 증가 : 폐기종, 고령, α_1 -antitrypsin부족 ③ Q가 감소하니까 V/Q는 결국 증가 ④ '폐포환기=호흡수*(Vt-Vd)'니까 Vd가 증가해서 환기가 감소하므로 날숨의 이산화탄소 분압이 감소한다고 할 수 있지 않을까요 ⑤ 좌측폐가 사강이니까 산소가 혈액으로 확산 되지못해서 폐포 내 산소 분압은 증가해있지 않을까요 아님 똑같은가		

문제번호	4	교수님	배재훈 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	호흡생리학		
답	①		
해설	< 정상치 > : PaCO₂ (35~45) / PaO₂ (80~100) / pH (7.35~7.45) / HCO₃(22~28mmHg) * 지금상태 : 포도당 ↑, PaCO₂ ↓, HCO₃?, pH ↓ * 다 필요없고 강 산증와서 호흡 빨라진건데 CO₂는 BBB 통과 후 H⁺가 돼서 중추화학수용체에 인식되고 그면 중추에서 흡식 자극을 일으키기 때문 (PaCO₂감소는 보상기전으로 인한 결과겠죠?)		

문제번호	5	교수님	최원일 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	총론, 호흡기질환의 주요증상, 호흡곤란의 감별 (?)		
답	④		
해설	* 오답률 엄청 높은 문제였습니다 ㅎㅎ * 문제에 나오는 증상 자체가 아주 전형적인 upper airway cough syndrome이라고 박재석 쌤이 말씀해주셨어요. 참고로 저희는 배운적이 없습니다. 최원일 쌤 원래 좀 그러세요...		

문제번호	6	교수님	최원일 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	총론, 호흡기질환의 주요증상, 호흡곤란의 감별		
답	④		
해설	* 2016년 야마 탄 문제 * 각 선택지(병태생리)의 임상양상(descriptor) ① : cannot get a deep breath, unsatisfying breath ② : heavy breathing, rapid breathing, breathing more ③ : increased work or effort of breathing ④ : chest tightness or constriction ⑤ : air hunger, need to breathe, urge to breathe * 강의록에 있는 표 내용입니다		

문제번호	7	교수님	최원일 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	호흡기 진찰 및 진단수기 (?)		
답	④		
해설	* 오답률 엄청 높은 문제였습니다 ㅎㅎ 1. 호흡음 감소 : mucus차서 기도 막힐 때, emphysema, pleural space에 공기나 액체 차있을 때 2. 타진에서 공명음 : emphysema, 기흉 * 결국 기흉, 폐기종 뭐 이런거 묻는거 같은데 ①은 hyperinflation, ③은 섬유화였던거 같네요 나머지 사진은... ㅎ		

문제번호	8	교수님	최원일 교수님		
해설자	박소현	감수자			
주제	호흡기 진찰 및 진단수기				
답	⑤				
해설	* 오답률이 높았던 거 같네요				
		pitch	intensity	duration	흡기/호기
	(fine) crackles	high	low	disconti-	inspirato-
	wheezes	high	?	contin-	expirato-
	rhonchi	low	?	contin-	<u>both(구글)</u>
	stridor	high	high	contin-	inspirato-
	* coarse crackles이란 애도 있는데 흡기, 호기 둘다 나타난다는 거 말고는 특징을 잘 모르겠습니다.				
* 밑줄 친 거는 구글내용이에요					
* 강의록에 있는 표 내용입니다					

문제번호	9	교수님	노병학 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	정상 흉부질환의 영상의학 소견 및 검사법		
답	③		
해설	① 노출정도(투과도) : intervertebral disc space가 겨우 보일정도 ② 좌폐문이 1~2cm 정도 높다 ④ 8번째 아니고 10번째 ⑤ PA 설명		

문제번호	10	교수님	노병학 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	정상 흉부질환의 영상의학 소견 및 검사법		
답	①		
해설	 A : middle lobar branch B : lower lobar branch * 배울 땐 요청도로 배웠지만 middle branch랑 같은 level에서 나타나니까 B는 구체적으로 sup. branch라는 걸 알 수 있습니다. * 나머지 4개의 basal branch는 한 단면에서 다 같이 나타나니까 당연히 아니겠죠~		

문제번호	11	교수님	노병학 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	흉부질환의 영상의학 소견 유형 분석		
답	④		
해설	* x사진 이외에 별거 안 주고 사진상 nodule이나 mass가 보이면 다음에 해야 되는 건 '이전사진과 비교'~~ * 쌤이 매년 강조하시는 내용입니다		

문제번호	12	교수님	노병학 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	흉부질환의 영상의학 소견 유형 분석		
답	②		
해설	① 폐암은 nodule이나 mass형태로 나타나겠죠 ②⑤ 심장과 좌 우측경계면이 없어졌으므로 실루엣징후+이고, 이는 우측심장과 근접한 부분인 우중엽 병변임을 알 수 있습니다. lat. view에서도 sternum뒤에 하얀 병변이 있고 infrahilar lucency는 잘 유지돼있네요. ③ costophrenic angle이 뾰족하니까 흉막삼출은 아니겠네요 ④ 기강경화(consolidation)은 폐혈관음영이 안보일정도로 하얗고 간유리음영(Ground Glass Opacity)는 폐혈관음영이 보일정도로 약간 하얀 건데 병변부 폐혈관음영이 안보이네요. 쌤이 헛갈리면 거의 대부분 consolidation이니 찍으라고 하셨어요.		

문제번호	13	교수님	최희정 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	소아 호흡기의 발달 및 영유아 호흡기의 특성		
답	③		
해설	① 신생아 정상호흡수가 30~40회/분이긴 한데 입원할 정도는 아닌가바여... ② 영유아는 늑골에 연골부분이 많고, 호흡근이 피로에 취약한 제2형 속성 연속 섬유인데다, 기도가 좁아 저항이 높아서 기도폐쇄 잘 일어남 ④ 영유아는 기도 내 점액선의 밀도가 높아 점액분비가 많다 ⑤ 신생아는 주로 비강으로 호흡해서 코막힘 심하면 호흡곤란 가능		

문제번호	14	교수님	최희정 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	소아 호흡기의 발달 및 영유아 호흡기의 특성		
답	④		
해설	① 흉곽외기도는 몇 개 없어서 폐쇄정도가 심하다 ② 일방폐쇄에 대한 설명 ③ 흡기시간 길어진다. ⑤ $R = \frac{8l\eta}{\pi r^4}$ (l : 관의 길이/ η : 가스의 점도/ r : 반지름) * 간단하게 폐쇄 시 흉곽외는 흡기/흡각내는 호기가 힘들고, * 부분폐쇄는 in(o),out(o)/일방폐쇄는 in(o),out(x)/완전폐쇄는 in(x),out(x)라고 생각하면 됩니다.		

문제번호	15	교수님	최희정 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	소아 호흡기 질환의 진단, 호흡부전 및 호흡관리		
답	⑤		
해설	* 코 별령, 늑간 함몰은 호흡곤란의 증상, 호흡부전($\text{PaO}_2 \leq 60$ or $\text{PaCO}_2 \geq 50$)의 조건을 만족. 즉 호흡부전이다. ① 이 친구는 산소요법의 적응증 중 급성저산소혈증($\text{PaO}_2 \leq 60$, $\text{SaO}_2 \leq 90\%$)을 만족하므로 산소요법을 먼저 해야합니다. 기계호흡은 산소요법에도 반응 없을 때 합니다. * 기계환기요법의 적응증 : 60% 이상의 산소투여에도 $\text{PaO}_2 \leq 60$, $\text{PaCO}_2 \geq 60$, $\text{pH} < 7.25$일 때 ② 구글이 말하길 코캐놀라로 28~44% 산소를 주입한다네요. 쌤 강의록에도 저유량 산소공급법의 하나로 코캐놀라가 있습니다. ③ 산소 요법의 부작용으로 superoxide로 인한 독성이 있어 hypoxia 아기한테 high O_2를 주면 안 되긴 하나 잘 조절해서 주면 되나봅니다. ④ 애기가 열이 나니 당연 감염에 대한 검사 해야죠.		

문제번호	16	교수님	최희정 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	소아 선천성 호흡기 질환, 비감염성 질환, 흉막 질환		
답	④		
해설	* 2012년도 야마에 있던 문제인데 2013~2016년동안 몇 번 내신 문제이지 않을까 생각합니다. 최희정쌤은 고대야마까지 찾아볼 필요는 없는 분이라. ④ 울거나 수유할 때, 누워있을 때 악화되고, 엎어 누이면 호전되는 것은 선천 후두 협착증, 후두 연화증의 특징적인 증상입니다.		

문제번호	17	교수님	최희정 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염		
답	③		
해설	* 감염 1~3일 후부터 코막힘, 콧물 → 감기 * 유치원, 놀이방에 다니면 감기빈도가 증가 ① rhinovirus가 가장 흔한 원인 ②⑤ 항생제 말고 항바이러스제 써야되고, 재발이야 맨날 하는거고 ③ 감기에서 가장 흔한 합병증이 중이염, 그다음이 부비동염. 이 두 개 동반되면 그때 항생제 써야 됨 ④ Reye 증후군 때문에 aspirin은 쓰면 안 됨		

문제번호	18	교수님	최희정 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염		
답	④		
해설	* 오답률 높은 문제입니다 * 급성 세기관지염 - 생후 2세 이전에 주로 발생, 영아입원의 가장 흔한 원인 - 흉부x선에서 폐의 과팽창 관찰 (rib이 7~8개까지 보여야 정상인데 그보다 더 보임) * 증상이 좀 비특이적인 느낌이라 급성세기관지염을 한 번에 생각해내기 힘들 수 있는데 소아에만 있는 병이라 소아에서 꽤 중요하다보니 2세 이전에 하기도감염같다 그러면 일단 의심해봅시다. 폐렴, 폐농양 아닌데 흉부사진을 준 것도 좀 냄새가 나네요. * 책에 치료가 많이 적혀있긴 한데 확립된 치료가 없어서 주로 supportive care합니다. ① 시원하고 습도를 높인 산소를 투여해야 함 ② 호흡곤란 있으면 입원해야하나 진정제는 가능한 피한다. ③ 책에 '항생제?' 이렇게 적혀있네요 :: ⑤ 책에 '항바이러스제 ribavirin의 분무?'라고 적혀있네요ㅋㅋ		

문제번호	19	교수님	최희정 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염		
답	①		
해설	* 경경거리는 기침, 쉼 목소리, 흡기 협착음, 호흡곤란 → 크루프 * 크루프 : 바이러스가 주 원인, 특히 Parainfluenza(75%)		

문제번호	20	교수님	최희정 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	소아 선천성 호흡기 질환, 비감염성 질환, 흉막 질환		
답	③		
해설	* 오답률 높은 문제입니다. * 기도 이물인거는 다 아는데 ③이나 ⑤이냐가 문제죠. ⑤하임리히는 기도 이물로 인한 질식일 때 하는 응급처치일 뿐 깊숙이 박힌 건 못 빼내고, 이미 병원에 와있는데 하임리히를 할 이유는 없다고 박재석쌤이 말씀하셨습니다. 기도 이물에 대한 기본적인 치료는 기관지경입니다.		

문제번호	21	교수님	최순옥 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	신생아 및 소아의 외과적 호흡 곤란증		
답	⑤		
해설	* 2016년 야마를 조금 변형한 문제(답선지는 동일) * 쌤 강의록에 있는 사진 1. 처음 수유할 때 기침과 호흡곤란, 양수과다증, 입안에 침과 분비물 많음 → esophageal atresia 2. GI에 gas 있으니까 type C or D (쌤 강의록에는 type C라고 함) ①② : 새로운 선지 / ③④⑤ : 2016야마와 동일한 선지		

문제번호	22	교수님	최순옥 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	신생아 및 소아의 외과적 호흡 곤란증		
답	③		
해설	* 쌤 강의록에 있는 사진 1. 호흡곤란, 청색증, x사진에 흉부까지 올라와있는 intestine → congenital diaphragmatic hernia 2. CDH의 예후가 나쁠 때 - 증상이 일찍 나타날수록 ① - pulmonary hypoplasia가 심할수록 ②,③,⑤ - 양수과다가 심할수록 ② - 폐동맥고혈압이 오래 지속될수록 ④ ② : 위가 탈장되면 양수과다생김 (양수가 proximal jejunum에서 흡수되니까) / 간이 탈장되면 공간이 부족하니까 폐형성 문제		

문제번호	23	교수님	이희정 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	소아 영상의학		
답	④		
해설	* 이희정쌤 ppt에서 너무 찾기 힘들어서 쌤 파트가 맞나 의심될 정도이긴 한데 쌤 문제 맞는 거 같아요... 이희정쌤 문제가 원래 좀 공부한 보람이 없습니다... * 그냥 상식적으로 '애는 호흡기 발달이 완전하지 못하다'로 풀 수밖에 없는 거 같아요 ㅜㅜ 죄송합니다... ②③ : 쌤 ppt에 '소아는 폐혈관 발달이 덜 돼서 안쪽 1/3에만 보이고, airway가 완전히 열려 있지 않아 air-bronchogram이 보인다'로 vascularity, conductance가 안 좋다고 풀 수 있을 거 같네요.		

문제번호	24	교수님	이희정 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	소아 영상의학		
답	①		
해설	* 강의록에 bronchiolitis의 예시로 있는 사진 (수업 안한 부분임...) - 사진 설명에 bronchospasm-airtrapping, hyperaeration, flattened diaphragm, widening of retrosternal space, bronchial thickening이라고 적혀있네요.... * 원래 소아 횡격막은 6th~7th rib의 ant, 8th rib의 post에 걸쳐있어야 되는데 애는 횡격막이 내려와 있기는 합니다. (다른 선지에서 굳이 선택할 게 없기도 하고요.... ㅎㅎ)		

문제번호	25	교수님	박재석 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	폐기능검사 및 판독		
답	①		
해설	* restrictive-parenchymal ; sarcoidosis, <u>IPF</u>, pneumoconiosis, ILD(drug, radiation관련) * 폐기능검사 결과 1. 제한성(보통 parenchymal을 의미) : TLC ↓, DLco ↓ (아마?), FVC ↓, FEV1 ↓, FEV1/FVC 정상or ↑ 2. 폐쇄성 : TLC 정상or ↑, DLco 케바케, FVC ↓, FEV1 ↓, FEV1/FVC ↓ ※ 폐기능검사 판독순서 1. FEV1/FVC < 70% → 폐쇄성 2. FVC < 80% → 제한성 3. TLC 감소여부 : (혼합형에서) 제한성 확진 4. DLco		

문제번호	26	교수님	박재석 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	폐기능검사 및 판독		
답	⑤		
해설	* 청진 시 싹싹거림은 좁은 기도를 빠른 기류가 통과한다는 의미 → 폐쇄성 * 폐기능검사 결과 1. 제한성(보통 parenchymal을 의미) : TLC ↓, DLco ↓ (아마?), FVC ↓, FEV1 ↓, FEV1/FVC 정상or ↑ 2. 폐쇄성 : TLC 정상or ↑, DLco 케바케, FVC ↓, FEV1 ↓, FEV1/FVC ↓		

문제번호	27	교수님	박재석 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	동맥혈가스분석/저산소혈증		
답	③		
해설	*1. ABGA 정상수치 : pH(7.35-7.45) / PaCO_2(35-45.) / PaO_2(80-100) / HCO_3(22-26[mEq/L]) *2. 증감 방향이 $\text{PCO}_2 = \text{HCO}_3 = \text{pH}$: 대사성 ↔ pH : 호흡성 *3. 호흡성산증에서의 예상 HCO_3 = 24 + r[급성일 때] 0.1 * (급성발생 후 PaCO_2 - 급성발생 전 PaCO_2) ~[만성일 때] 0.4 * (만성발생 후 PaCO_2 - 만성발생 전 PaCO_2) ex1) 만성발생 시 : PaCO_2는 정상(40mmHg)→AmmHg로 변함 ⇒ 예상$\text{HCO}_3 = 24 + 0.4*(A-40)$ ex2) 급성발생 시 : PaCO_2는 정상(40mmHg)→BmmHg로 변함 ⇒ 예상$\text{HCO}_3 = 24 + 0.1*(B-40)$ ex3) 원래 만성가지고 있었는데 급성까지 와버리면 : PaCO_2는 정상(40mmHg)→만성(AmmHg)→급성(BmmHg) ⇒ 예상$\text{HCO}_3 = 24 + 0.4*(A-40) + 0.1*(B-A)$ *4. 호흡성산증에서 예상$\text{HCO}_3 >$ 측정HCO_3 ⇒ 대사산증 동반 = ⇒ 적절한 보상 < ⇒ 대사알칼리증 동반 *5 이 케이스 분석 1. $\text{pH} \downarrow \leftrightarrow \text{PaCO}_2 \uparrow = \text{HCO}_3 \uparrow \Rightarrow$ 급성호흡성산증 2. 예상$\text{HCO}_3 = 24 + 0.1*(80-40) = 28$ 3. 예상$\text{HCO}_3 =$ 측정$\text{HCO}_3 \Rightarrow$ 적절한 보상 4. 호흡산증이니까 당연히 저환기~~		

문제번호	28	교수님	박재석 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	동맥혈가스분석/저산소혈증		
답	②		
해설	* Hypoxemia 접근 순서 1. PaCO₂ : 환기 상태 괜찮니? 2. PAO₂(alveola)-PaO₂(artery) (<15가 정상) : 증가 시 shunt or V/Q mismatch / 아니면 환경문제 등등 ◇ PAO₂ = 150 - 1.25 * PaCO₂ 3. O₂줘서 교정가능? : o → V/Q mismatch / x → shunt * 이 케이스 분석 1. PaCO₂ 정상 ⇒ 환기상태 괜찮네 2. PAO₂ = 150-1.25*40 = 100 → PAO₂-PaO₂ = 100-50 = 50 ⇒ shunt or V/Q mismatch 3. O₂줬는데 PaO₂ 교정안됐네 ⇒ shunt!!! ①③④⑤ : V/Q mismatch (③interstitial pneumonia는 interstitial lung disease에 들어갑니다. ILD는 2차 시험범위예요) ② : shunt		

문제번호	29	교수님	김현정 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	천식의 진단		
답	⑤		
해설	2015 천식 진료지침) <u>병력과 진찰 소견이 천식에 합당한 경우 천식 진단을 위해 호기 기류제한의 변동성 확인을 위한 검사를 시행</u> <u>기관지확장제 반응 양성</u> 2주간 1일 2회 측정된 PEF의 과도한 변동성 항염증 치료 4주 후 폐기능의 유의한 개선 운동 유발시험 양성 <u>기관지유발시험양성(메타콜린 / 히스타민 / 만니톨 등)</u> 매 방문 시 측정된 폐기능의 과도한 변동성 H) <u>메타콜린 또는 히스타민 유발 검사는 폐기능 검사가 정상인 환자에서 진단이 확실치 않을 때 사용할 수 있음</u>		

문제번호	30	교수님	김현정 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	천식의 진단		
답	④		
해설	병력에서 운동유발기관지수축이 의심되는 증례입니다. 2015 천식 진료지침) <u>병력과 진찰 소견이 천식에 합당한 경우 천식 진단을 위해 호기 기류제한의 변동성 확인을 위한 검사를 시행</u> 기관지확장제 반응 양성 2주간 1일 2회 측정한 PEF의 과도한 변동성 항염증 치료 4주 후 폐기능의 유의한 개선 운동 유발시험 양성 기관지유발시험양성(메타콜린 / 히스타민 / 만니톨 등) 매 방문 시 측정한 폐기능의 과도한 변동성 H) <u>알레르기 피부반응 검사</u> 알레르기성 천식에서 양성 소견을 보이며 내인성 천식에서는 음성을 보이고 천식 진단에 도움이 되지 않음		

문제번호	31	교수님	김현정 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	천식 조절 평가		
답	⑤		
해설	2015 천식 진료지침) 천식 증상 조절 일주일에 3번 이상의 주간 증상 <u>야간 증상</u> 일주일에 3번 이상의 증상완화제 사용 활동 제한		

문제번호	32	교수님	김현정 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	천식의 급성 악화		
답	②		
해설	진료지침에서 중증 급성악화에 해당하는 증례입니다. 중증 이상의 급성 악화가 발생한 천식 환자는 응급 의료기관으로 전원하여 진료합니다. 2015 천식 진료지침) ① 세균성 호흡기 감염이 없는 이상 권고되지 않음 ② <u>전신적 스테로이드제</u> ③ 급성 천식 악화가 아니필라시스나 혈관 부종과 합병된 경우에만 사용 ④ 진료지침에 언급이 없습니다. ⑤ 속효성 흡입 베타2 항진제		

문제번호	33	교수님	김현정 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	만성폐쇄성폐질환의 치료		
답	⑤		
해설	2017 COPD 진료지침) (다)군 환자 FEV1이 정상 예측치의 60% 미만이거나 지난 1년간 2회 이상 급성악화가 있었거나 입원할 정도로 심한 악화가 있었던 환자 (다)군 환자에서 LAMA+LABA를 처방 2017학년도 기준 수업은 2017 GOLD COPD Guideline으로 진행되었습니다.		

문제번호	34	교수님	김현정 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	만성폐쇄성폐질환의 치료		
답	②		
해설	H) <u>동맥혈 이산화탄소 분압이 45mmHg 초과인 환자에서 비침습적인 양압환기를 시행하여 사망률과 기관삽관의 필요성과 합병증 및 재원기간을 유의하게 줄임</u>		

문제번호	35	교수님	김현정 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	만성폐쇄성폐질환의 진단		
답	①		
해설	2014 COPD 진료지침) 나무, 동물 배설물, 석탄 등을 요리나 난방용 땔감으로 사용하는 경우 실내 공기 오염이 발생되며 이러한 실내 공기 오염도 COPD의 중요한 위험인자로 작용할 수 있다. <u>COPD를 진단하기 위해서는 폐활량측정이 필요</u> <u>COPD를 치료하기 위해 폐기능을 평가</u>		

문제번호	36	교수님	김현정 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	만성폐쇄성폐질환의 치료		
답	①		
해설	2014 COPD 진료지침) ① 금연, <u>호흡재활</u>, 인플루엔자 및 폐렴구균 백신접종과 동반질환의 치료를 같이 병행 <u>모든 병기의 COPD 환자들이 운동프로그램을 통하여 운동 능력이 향상되고, 호흡곤란, 피로감 등의 증상이 완화될 수 있음</u> ② SABA 혹은 SAMA의 효과가 만족스럽지 못할 경우 고려 가능 ③ 안정 산소포화도 88% 미만 또는 산소포화도 90% 미만이면서 폐성심이나 우심부전 동반된 경우 ④ 안정 시 COPD 환자에게 예방적 항생제 처방을 권장하지 않음 ⑤ 단독으로 권장되지 않음		

문제번호	37	교수님	박재석 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	폐렴의 치료		
답	⑤		
해설	2017 성인 지역사회획득 폐렴 항생제 사용지침) CURB-65 Score 3점으로 ICU에 입원하여 치료를 권고하는 증례입니다. <u>중환자실 입원 치료를 필요로 하는 환자는</u> <u>β-lactam + Azithromycin/Respiratory fluoroquinolone의 병용요법을 권장</u>		

문제번호	38	교수님	박재석 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	폐렴의 원인균		
답	③		
해설	강의록) 2009 지역사회획득 폐렴의 치료지침 권고안) 세균성 폐렴균 중 <i>S. pneumoniae</i> 가 가장 중요한 원인균으로서 보고에 따라 27~44%를 차지		

문제번호	39	교수님	박재석 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	폐농양의 치료		
답	⑤		
해설	CXR 상에서 우폐야에 Cavity와 내부의 Air-Fluid Lv.을 확인 병력과 임상증상과 폐농양을 의심할 수 있는 증례입니다. 강의록) 사용가능한 경험적 항생제 Clindamycin β -lactam/ β -lactamase inhibitor Carbapenem Metronidazole		

문제번호	40	교수님	박재석 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	기관지확장증		
답	④		
해설	* 쌤 강의록에 있는 사진 * 이 케이스에서 1. 만성기침, 화농성가래, 객혈, 거품소리 모두 기관지확장증 증상 2. 소아기에 홍역, 백일해 등 감염 후유증으로 기관지 확장증 많이 발생 3. 사진이 넘나 기관지확장증 (기관지확장증의 진단은 CT!)		

문제번호	41	교수님	권건영 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	기도질환(기관지천식 및 COPD, 소기도질환, 기관지확장증)의 병리		
답	②		
해설	* 침착되는 곳 / filtering&clearing mechanisms 1. $>10\mu\text{m}$: 코, 상기도 / nasal clearing (재채기, 기침, 삼킴) 2. $3\sim10\mu\text{m}$: trachea, bronchi / tracheobronchial clearance (mucociliary action, 삼킴, 가래뱉기) 3. $1\sim5\mu\text{m}$: terminal airways, 폐포 / alveolar clearance (Mf) * 미세먼지 : $10\mu\text{m}$이하 / 초미세먼지 : $2.5\mu\text{m}$이하 (네이버) * 미세먼지를 $3\sim10\mu\text{m}$크기라고 생각하면 ③④⑤는 다 폐포니까 빼고, ①은 cilia가 많아서 초기에는 침착이 안 일어날 거 같네요~		

문제번호	42	교수님	권건영 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	기도질환(기관지천식 및 COPD, 소기도질환, 기관지확장증)의 병리		
답	④		
해설	①②③⑤ : centriacinar emphysema(담배와 관련)에 대한 설명 ④ : centriacinar emphysema는 폐상부가 더 심함		

문제번호	43	교수님	노병학 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	폐렴의 영상의학		
답	②		
해설	* 열, 청진 상 거품소리라 폐렴인데, 사진이 consolidation, air-bronchogram(+)니까 lobar pneumo(폐포성, 대엽성 폐렴) * lobar pneumo의 원인 : Pneumococcus, <u>Klebsiella</u>가 대표적 ① G(-)니까 아마 기관지성폐렴? ② 폐포성폐렴 / 고령, 빈곤층, 음주자에서 호발 ③ 기관지성폐렴 / 폐하업 ④ 기관지성폐렴 / 고령, heavy smoker ⑤ 폐포성폐렴(어릴 때), 간질성폐렴(20대 후)		

문제번호	44	교수님	노병학 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	폐렴의 영상의학		
답	⑤		
해설	* 씹 강의를 통해 결핵파트에서 예시 그대로 있음 * 피가 섞인 가래를 동반한 기침, 오한, 식은땀, 체중 감소는 결핵의 대표적인 증상		

문제번호	45	교수님	박재석 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	폐렴의 진단		
답	③		
해설	강의록) 흉부방사선에서 새로운 폐 침윤이 있으면서 다음의 4가지 소견 중 하나 이상 발열($\geq 38^{\circ}\text{C}$) 또는 저체온($< 35^{\circ}\text{C}$) 새로운 기침과 가래 흉막성 흉통, 호흡곤란 청진시 이상음		

문제번호	46	교수님	박재석 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	만성폐쇄성폐질환의 진단		
답	②		
해설	2014 COPD 진료지침) COPD를 진단하기 위해서는 <u>폐활량측정이 필요</u> COPD를 치료하기 위해 <u>폐기능을 평가</u> 37.1℃는 정상체온의 범주에 해당하는 온도입니다. 폐렴이나 감염성 호흡기 질환에 의심할 수 있는 V/S이 부족하고 고령과 흡연의 전형적인 병력으로 COPD와 폐암을 가장 강력하게 의심할 수 있으며 현재 주증상에서 COPD의 진단을 우선시 하는 것이 합당하다고 판단됩니다.		

문제번호	47	교수님	장정희 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	호흡기계 약물 : 비충혈 완화		
답	⑤		
해설	강의록) 강의록의 해당약물 이상반응과 금기에 대한 설명입니다.		

문제번호	48	교수님	장정희 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	호흡기계 약물 : 폐렴 항생제		
답	⑤		
해설	강의록) 지용성, 염증과 상관없이 침투 용이한 항생제 : Fluoroquinolone, New macrolides, Tetracycline, Clindamycin, TMP/SMX 농도 의존적 항생제 : Fluoroquinolone 지역사회획득폐렴의 치료에 사용하는 항생제 : β -lactam $\pm$ macrolide, Respiratory fluoroquinolone 해당 내용에 모두 만족하는 항생제는 Respiratory fluoroquinolone에 해당하는 Levofloxacin		

문제번호	49	교수님	이성용 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	호흡기질환의 치료약제(1)		
답	⑤		
해설	* 다 맞대여...하하 죄송합니다		

문제번호	50	교수님	이성용 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	호흡기질환의 치료약제(1)		
답	④		
해설	* 선배 입으로 내려온 2016 야마입니다. 저는 그냥 깃연가 나오면 ipra다로 외우고 들어갔었어요.... ㅎㅎㅎㅎ ① methylxanthine계열 : 기관지 확장제는 맞지만 부작용으로 arrhythmia있음 ② (sodium cromoglycate라고 보통 표기됨) : 기관지 확장제 아니고 mast cell stabilizer임. 부작용은 적다 ③ β_2 agonist로 위급상황에 쓰이긴 하는 거 같은데(구글) 심부정맥 부작용이 적을 리가 없겠쥬. ④ Anti-cholinergics계열 : bronchoconstriction 억제, 점액분비 감소효과가 있어 기관지확장제로 사용되며, salbutamol과 혼합되어 COPD&천식에 쓰임. 부작용이 적어 안전하다. ⑤ selective β_1 receptor blocker계열 : 보통 심장병에 쓰이고 COPD에는 안 쓰이는 거 같은데... (구글)		